

NS	
REGINA HEIT KERBER	
RE 89	PESO: 48 ALTURA: 162 PROFISSÃO: Do lar - Artesã
SINTOMAS: sonolência diurna / cansaço / Dormido	
QUEIXAS: Memória e concentração ruim.	
MEDICAMENTOS: Pradaxa / espironolactona / Excedos. Vitamina / Magnésio.	
MÉDICO: Dr. Pedro / Dr. Eduardo	
EXERCÍCIO FÍSICO: fisioterapia 1x semana	
HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: N ALMOÇO: S LANCHE: S JANTAR: S 20:00	
HORA QUE DORME: 00:00 - 1h HORA QUE ACORDA: 10:30 - 12h.	
COCHILO ☒ SIM () NÃO DORME ACOMPANHADO () SIM () NÃO () EVENTUAL	
BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA () NÃO as vezes vinho/chopp.	
FUMO () SIM () MAÇO/DIA ☒ NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO: fumante passiva	
TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 122x	
CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: 90cm CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:	
OVERLAP: não MALLAMPATI: II IAH: 25.6 SPO2: 86%	
PATOLOGIAS ASSOCIADAS: estereotomia	
CIRURGIAS: () NASAL () AMIGDALECTOMIA Catarata (sim).	
HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE:	
COMORBIDADE: () RESPIRATÓRIA () ENDÓCRINA () CARDÍACA	
() ORTOPÉDICA () NEUROLÓGICA () OUTROS (suspeito AVC transitório)	
edema lombar / torácico	
18/12 23	P = 7.4 cmH ₂ O IAH = 1.1 m. de uso: 8h40' Fuga = 6.3 l/min.
05/01 24	P = 7.4 cmH ₂ O IAH = 6.4 e/ev m. de uso: 5h24' Fuga = 31.3 Está um pouco resistente ao uso fua. *Comprou Elite hoje* Ana
01/02 24	P = 7.4 cmH ₂ O IAH = 3.0 m. de uso: 6h54' Bem adaptado fua.
20/02 24	P = 7.4 cmH ₂ O IAH = 3.2 e/ev m. de uso: 7h25' Fuga = 2.8 l/min. fua.
21/03 24	P = 7.4 cmH ₂ O IAH = 4.9 e/ev m. de uso: 6h30' fua.
10/05 24	P = 7.4 cmH ₂ O IAH = 4.0 e/ev m. de uso: 6h Bem adaptado fua.

06/06 P=7.4 cmH₂O
24 IAH= 0.5 e/h
m. de uso: 5h43'
fuga= 14.5 lpm

flua

16/08/24 P=7.4 cmH₂O
IAH= 1.0 e/h
m de uso: 4h54'
fuga: 7.2 l/m

Utilizando 9 dias < 4h
Oriento colocação da
mascara e aumentar
horas de uso

Natasha

03/10/24 P=7.4 cmH₂O
IAH= 2.3 e/h
m de uso: 5h15'
fuga: 9.1 l/m

* Troco filtro

Natasha

01/11
24 P=7.4 cmH₂O
IAH= 0.9 e/h
m. de uso: ~~6h34lpm~~ 6h34lpm
fuga= 24 lpm

14/05/25 P=7.4 cmH₂O
IAH= 1.2 e/h Desconhecido: 1.96 e/h
m de uso: 6h18'
fuga: 43.1 l/m

Natasha

16/07/25 P=7.4 cmH₂O
IAH= 2.6 e/h
m. de uso= 4.8 lpm
fuga= 4.8 lpm.

flua

Nome: REGINA HEIT KERBER
Data de Nascimento: 30-3-1934
IMC: 30,47
Sexo: FEMININO
Data do exame: 05-08-2022

Peso: 78 kg
Altura: 1,60 m
Médico: DR. ALEXANDRE COELHO
MARQUES
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 05-08-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 539,5. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 31,5 e 153,5 minutos. O tempo total de sono foi de 410,5, eficiência de 76,1% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,6%; estágio N2: 60,7%; estágio N3: 16,8%; sono REM: 20,0%. O índice de despertares foi de 13,0/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 25,6/hora, sendo elas 68 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 47 hipopnéias. A SpO2 média foi de 93% e mínima de 86%, permanecendo 1,9% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 55 - 107 bpm e NREM de 44 - 138 bpm.

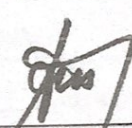
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (11), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 25,6/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (mín. SaO2=86%);
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco no traçado.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157